

# 근거기반의 작업치료와 제도의 이해

근거기반실무(EBP)

병원 수가체계

어린이 재활의료기관 시범사업

ICF·작업기반 실무

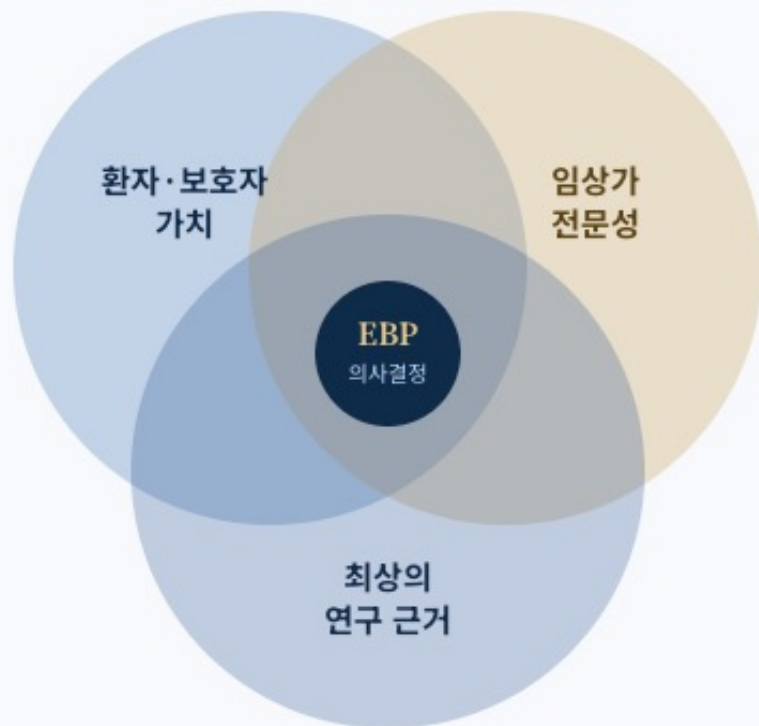
대한작업치료사협회 · 병원기반아동작업치료 TFT

푸르메재단 넥슨어린이재활병원 **함형광**

강의 흐름 **EBP** → 수가제도 → 시범사업 → **ICF·작업기반**

- 근거기반 작업치료의 핵심

## 임상 의사결정의 3요소



- **환자·보호자의 가치**  
Patient / Family Values  
아동과 가족이 무엇을 의미 있게 여기는지 — 목표 설정의 출발점.
- **임상가의 전문성**  
Clinical Expertise  
임상 경험과 추론으로 근거를 개별 아동에게 맞게 적용하는 힘.
- **최상의 연구 근거**  
Best Research Evidence  
현재 가능한 가장 신뢰도 높은 연구 결과를 임상에 반영.

● NOVAK ET AL., 2019

## 신호등 체계 Traffic Light System



### GREEN · Go!

반드시 시행 — 근거 수준이 높은 중재

과제지향 훈련 · 양수집중훈련(HABIT) · 환경 중심 접근

### YELLOW · Measure!

주의 깊게 적용하고 결과를 측정해야 하는 중재

효과 근거가 제한적 — 적용 시 반드시 성과 측정과 모니터링을 동반.

### RED · Stop!

근거에 따라 Green으로 무게중심을 옮기는 영역

효과 근거가 약한 중재는 축소, 효과가 입증된 Green 중재로 치료 시간을 집중.

EBP는 논문을 읽는 일이 아니라, 제한된 치료 시간 안에서 가장 효과적인(Green) 치료를 선택하는 '윤리적 책임'.

● 출처 · 검색 키워드 [Novak et al. \(2019\), Current Neurology and Neuroscience Reports](#) ↗ [Novak & Honan \(2019\), Aust Occup Ther J](#) · 아동 작업치료 효과 체계적 고찰 ↗

🔍 Evidence Alert Traffic Light System

🔍 Novak 2019 cerebral palsy interventions

- NOVAK & HONAN, 2019 · 작업치료 체계적 고찰

# GREEN — “반드시 하라(Do it)” 중재

**GREEN · Go!** 높은 수준의 근거로 효과가 입증된 작업치료 중재 (27개 영역)

- 행동중재 ABA·Triple P·토큰경제
- 양손 협응 훈련 Bimanual
- 코칭 Coaching
- 인지중재 Cog-Fun·CAPS
- CO-OP
- 건축제한운동 CIMT
- CIMT + 양손훈련
- 맥락 중심 중재 Context-Focused
- Ditto (절차통증)
- 조기중재 ABA·발달돌봄
- 가족중심 서비스
- 섭식 중재 Feeding
- 목표지향 훈련 GDT
- 글씨쓰기 과제특이 연습
- 가정 프로그램 Home Program
- 공동주의 Joint Attention
- 정신건강 중재
- 보틀리눔 독소 후 작업치료
- 키네시오 테이핑
- 통증 관리
- 부모 교육
- 그림교환의사소통 PECS
- 자세잡기 Positioning
- 욕창·압력 관리
- 사회기술 훈련
- 트레드밀 훈련
- 체중관리 'Mighty Moves'

## 30%

135개 중재 지표 중 40개가 Green  
= “반드시 하라(Do it)” 등급

Green · Do It — 30%

Yellow · Measure — 66%

Red · Stop — 4%

### ▲ 활동(Activity) 수준에 집중

Green 중재는 ICF **활동 수준**에서 가장 많음  
(Green 14 > Yellow 13 > Red 0).

일상생활 기술을 ‘**top-down**’으로 훈련하는  
것이 작업치료의 핵심 강점

— worth-it line 위 운동·기능 Green 중재의  
**100%가 top-down** 접근

- 출처 Novak & Honan (2019), Aust Occup Ther J, 66:258-273 7



- NOVAK & HONAN, 2019 · 작업치료 체계적 고찰

## YELLOW & RED — “측정하라 / 멈춰 살피라”

### YELLOW · Measure!

효과 근거가 불충분한 중재

66%

전체 135개 중 89개 — 가장 큰 비중. 효과를 단정할 근거가 부족하므로 금지가 아니라, 적용하되 반드시 민감한 성과측정으로 진전 모니터링이 필요한 영역. (신체기능·환경 수준에서 가장 흔한 코드)

대표 예시

감각통합치료 SI

감각 기반 접근

신경발달치료 NDT

보조기·스플린트

캐스팅(일부)

히포테라피

보조공학·태블릿

시지각·시운동 훈련

감각 훈련

고유수용성 중재

마사지

명상

DIR / Floortime

수면위생

심상 훈련

### RED · Stop!

다시 살펴볼 중재

4%

전체 135개 중 6개로 가장 적음. 모두 신체기능·구조 수준의 중재였고, worth-it line 아래 운동 중재의 100%가 'bottom-up' 접근.

근거가 된 연구

수동적 신장 (Katalinic 2010)

가중담요·수면 (Gringras 2014)

논문의 결론은 “하지 말라”는 비난이 아니라, 이미 효과가 입증된 top-down 대안이 존재하므로 같은 목표라면 Green 중재로 자원을 옮길 수 있다는 제언.

top-down 접근의 효과크기는 0.89, bottom-up은 0.12 — 신호등은 ‘좋고 나쁨’의 낙인이 아니라, 제한된 치료 시간을 어디에 쓸지 정하는 의사결정 지도.

- 출처 Novak & Honan (2019), *Aust Occup Ther J*, 66:258-273 ↗

- 병원 수가체계의 이해

## 행위별 수가제의 기본 원리

병원 시스템 내 수가가 만들어지는 공식.

### 상대가치점수

Relative Value Score

의료행위의 노력·시간·위험도를  
상대적으로 점수화



### 환산지수

Conversion Factor

점수를 금액으로 바꾸는  
유형별 단가



### 수가

Fee · Price

실제 청구·보상되는  
치료의 가격

- 건강보험 요양급여비용 기준

## 작업치료 주요 산정 코드

빈도 높은 수가 ①

### 특수작업치료

대상·시간 등 산정 지침과 인정 기준 충족 시 청구 인정.

빈도 높은 수가 ②

### 일상생활동작(ADL) 훈련

작업기반 실무와 직접 맞는 코드 — 목표·기록의 일관성이 핵심.

빈도 높은 수가 ③

### 연하재활치료

적응증과 평가 근거가 명확할 때 인정 — 산정 조건 확인 필수.

#### 실무 포인트

각 코드의 상대가치점수와 인정 기준을 정확히 알수록, 제공한 치료와 **전문성이 제도 안에서 정당하게 인정·보상**. 산정 기준을 아는 것은 곧 우리의 근거를 제도의 언어로 설명하는 일.

- 인정비급여 · 신의료기술평가

## 휠체어 조작기술 훈련 WSTP

2023년 신의료기술 등재

### 기술의 정의

휠체어 조작 경험이 없거나 조작능력 개선이 필요한 환자에게 **훈련 프로그램을 적용**하여 휠체어 조작능력을 개선시키는 기술.

▶ 적용 프로그램: 캐나다 Dalhousie University가 개발한  
**Wheelchair Skills Training Program (WSTP)**

#### ● 안전성

훈련 과정에서 부상 보고가 없어 **안전한 기술**로 평가.

#### ● 유효성

기존 재활치료 수행군과 비교 시 휠체어 조작기술 평가점수가 전반적으로 **유의하게 개선** — 유효한 기술로 평가.

#### 제도 맥락

신의료기술평가제도(2007 도입)는 검증되지 않은 의료기술의 무분별한 사용을 막고 국민 건강권을 보호하는 장치 — 본 기술은 2023년 제4차 보건복지부 신의료기술평가위원회에서 안전성·유효성을 인정받아 최종 심의·고시.

- 출처 · 검색 키워드 한국보건 의료연구원(NECA) · 신의료기술평가

🔍 휠체어 조작기술 훈련 신의료기술

🔍 Wheelchair Skills Training Program



- 제도 전환의 배경

## 건강보험 수가에서 시범사업으로

행위별 수가제는 개별 치료 행위를 표준 기준으로 보상하는 체계. 성인·일반 재활 중심으로 설계되어, 아동 재활 고유의 요구를 담기에는 구조적 한계 존재.

미충족 영역 ①

### 발달영역별 통합기능평가

영역별 표준화된 검사항목을 통합한 평가에 대한 보상 근거 부족.

미충족 영역 ②

### 종합치료계획 수립

재활의학과 전문의 주관 하에 각 분야별 담당자가 참여하는 종합치료계획 수립의 보상 부재.

미충족 영역 ③

### 지역사회 자원연계

지역사회 자원연계 등 보건·복지 연계서비스의 산정 기준 부재.

기존 건강보험 수가체계 → 어린이 재활의료기관 시범사업

- 제2기 어린이 재활의료기관 시범사업

## 주요 내용



### 종합치료계획 수립 · 교육 · 상담

재활의학과 전문의 주관 하에 간호사·물리치료사 등 각 분야별 담당자가 참여하는 종합치료계획 수립을 보상 — 통합계획교육상담료.



### 지역사회연계료 신설

지역사회 자원연계 활동을 기관 내 활동·현장 방문활동으로 구분, 지역사회연계 의뢰서로 산정.

병원 내 기능 향상 → 지역사회로의 참여

- 운영지침 기반 실무 Q&A

## 현장에서 자주 묻는 질문

Q. 학교·복지관 연계 시 지역사회연계로 산정 방식은?

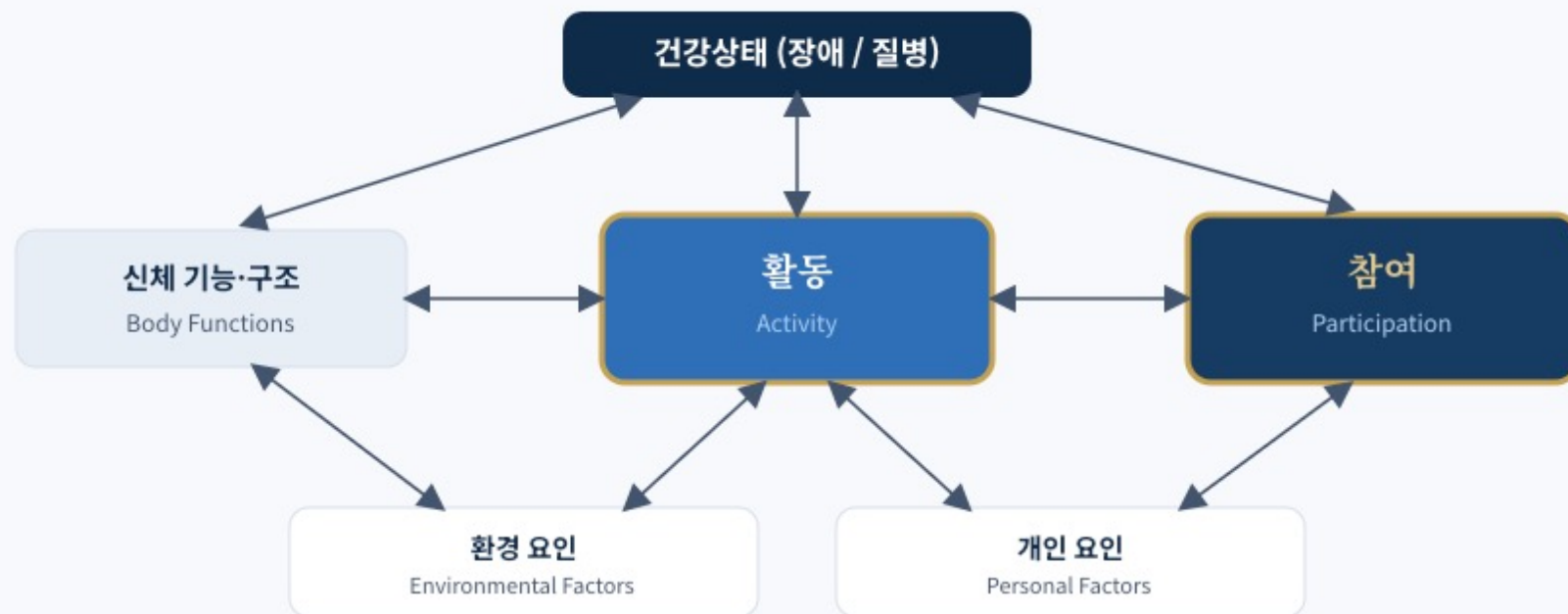


Q. '통합계획교육상담료'의 참여 인력 기준은?



- 참여 중심 치료를 설명하는 공통 언어

# ICF 모델의 재해석



- 우리가 하는 건 '작업치료'

## 작업의 3가지 스펙트럼

위계가 아니라, 내가 하는 작업치료를 정확히 설명하는 언어.

1

### 작업중심

Occupation-centered

작업치료사로서 우리의 정체성이자 철학 — 모든 판단의 바탕이 되는 관점.

2

### 작업기반

Occupation-based

의미 있는 작업 그 자체를 '치료적 수단'으로 사용하는 실천.

3

### 작업초점

Occupation-focused

치료의 결과와 목표가 작업에 맞춰지는 것.

- 출처 · 검색 키워드 Fisher AG (2013), Scandinavian Journal of Occupational Therapy <sup>가</sup>

occupation-centred based focused Fisher

OTIPM 작업기반 실무



- 참고 자료 · 검색 키워드

## 더 찾아보기

아래 키워드로 원문·지침을 직접 검색하거나, 출처를 눌러 바로 이동.

근거 신호등  
Part 1 · EBP

Novak et al. (2019)

🔍 Evidence Alert Traffic Light System

수가 체계  
Part 2 · 수가

건강보험심사평가원

🔍 건강보험 요양급여비용

🔍 상대가치점수 환산지수

작업치료 산정  
Part 2 · 수가

요양급여비용 산정지침

🔍 작업치료 수가 산정지침

시범사업  
Part 3 · 정책

보건복지부

🔍 어린이 재활의료기관 시범사업

🔍 통합계획교육상담료 지역사회연계료

운영지침  
Part 3 · 실무

시범사업 운영지침

🔍 어린이 재활의료기관 운영지침

ICF  
Part 4 · 분류

WHO · ICF

🔍 국제기능장애건강분류

작업 스펙트럼  
Part 4 · OT

Fisher AG (2013)

🔍 occupation-centred based focused